SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO UF0130



U.F. 0130:

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones.

UNIDAD FORMATIVA 2: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES (UF0130; 50 horas)



Ines Sabbatini

Contenidos

1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de la institución

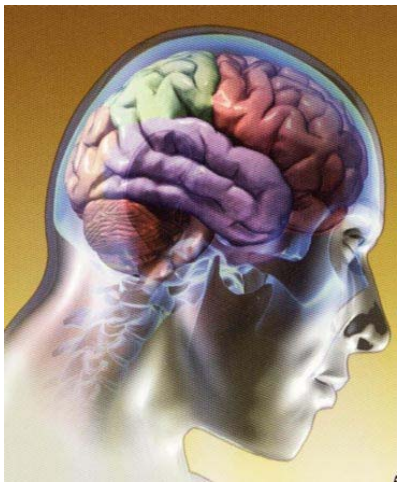
Las funciones cognitivas son todo un repertorio de capacidades sofisticadas tales como la memoria, la atención, la orientación espacial, temporal y personal, el lenguaje, el razonamiento, la capacidad visoespacial, etc.

Estas funciones cognitivas nos permiten efectuar actividades como elaborar un itinerario, recordar un número de teléfono, reconocer un rostro, calcular mentalmente, conducir, tocar el piano o, simplemente, leer.

Ellas son, por tanto, la base del pensamiento, de la acción y de la comunicación.

La estimulación cognitiva es un grupo de actividades orientadas a mantener o mejorar las funciones cognitivas de los pacientes (por ejemplo, mejorar la memoria) y las habilidades necesarias para la vida diaria (por ejemplo, el manejo del dinero, comunicarse por teléfono, orientarse o no perderse en una ciudad, realizar las tareas domésticas, etc).

1.1.- Técnicas para el entrenamiento de la memoria.



La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información

En el proceso de almacenamiento de los conocimientos en la memoria es posible diferenciar las siguientes fases:

- codificación o registro: recepción, procesamiento y combinación de la información recibida.
- almacenamiento: creación de un registro permanente de la información codificada.
- recuperación: recordar la información almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o actividad

Tipos de memoria atendiendo a:

Clasificación por contenido o utilización

- Memoria de referencia: Contiene la información reciente y remota obtenida por experiencias previas.
- Memoria de trabajo: Se aplica a un proceso activo que está siendo actualizado de manera continua por la experiencia de un momento determinado.
- Memoria episódica: Contiene la información relativa a sucesos acontecidos en un momento y lugar determinados.
- Memoria semántica: Contiene información que no varía, como por ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales de provincia de Andalucía.
- Memoria declarativa (o explícita): Contiene los hechos del mundo y los acontecimientos personales del pasado que es necesario recuperar de manera consciente para recordarlos.
- Memoria de procedimiento (o implícita): Aprendizaje y conservación de destrezas y habilidades, como peinarse o montar en bicicleta. Estos procedimientos se automatizan y no precisan de una ejecución consciente.

Clasificación según su duración

- Memoria sensorial es inmediata.

  Subtipos de esta son la memoria visual (icónica) y la auditiva (ecónica)

  Los posibles trastornos de la misma son:

- Imposibilidad de retener la información.
- Captación de estímulos sensoriales y olvido inmediato.

Por ejemplo huele a gas pero no o reconoce

- Memoria inmediata (memoria a corto plazo): Duración de menos de un minuto, y limitada a unos pocos objetos. También se llama memoria operativa

  Los posibles trastornos de la misma son:

  - Disminución de la capacidad de almacenamiento de información nueva.
  - Olvido de las instrucciones inmediatas.
  - Alteración en la transferencia de información a la memoria a largo plazo.
  - Deterioro en el proceso de aprendizaje.

  Son indicadores de que se está alterando:

  - Olvida la pregunta que le acabamos de formular.
  - Está viendo la televisión y no recuerda de qué programa se trata.
  - Le presentamos a un nuevo residente y olvida su nombre al poco tiempo.
  - Se desplaza al salón-comedor y para por el camino sin saber adónde se dirigía.
  - Le cuesta seguir el argumento de una historia que le contamos o una película que está viendo.
  - Apenas consigue argumentar una opinión durante una conversación.
  - Olvida lo que recientemente ha leído.
  - No recuerda el paso siguiente a realizar en una actividad de la vida diaria.
- Memoria remota o a largo plazo: Mantiene la información desde semanas hasta toda la vida. Son parte de esta la memoria episódica y la procedimental.

  Los posibles trastornos de la misma son

  - Afectación del proceso de recuperación de datos.
  - La información se encuentra almacenada pero el paciente no puede tener acceso a ella; no la recuerda.
  - En los cuadros de deterioro leve, la memoria episódica parece verse más afectada que la memoria semántica.
  - La memoria procedimental se conserva en buen estado, prácticamente, hasta la última fase de una demencia.

- Se muestra incapaz de definir objetos cotidianos.
- Olvida fechas o eventos relevantes.
- Parece no conocer el significado de las palabras de uso ordinario.
- Altera el orden de las secuencias de hábitos, como vestirse, lavarse los dientes, etc.
- Se olvida en qué sala se imparte un taller al que asiste desde hace tiempo.
- No recuerda el nombre de sus compañeros o cuidadores.

La intervención cognitiva en pacientes con demencia según nivel de deterioro

Nivel leve:

Lo que quiere lograr es conservar los conocimientos generales, mantener la mecánica de la escritura y la lectura. Pero sin abandonar el estímulo de capacidades básicas, como la atención y la orientación.

Nivel moderado

Se usan más estímulos básicos y el objetivo es preservar sobre todo la memoria remota, sin abandonar los aspectos instrumentales como el lenguaje, la percepción visual y las destrezas motoras. La lectura en esta fase sigue siendo una de las capacidades residuales del paciente, por lo que se aconseja su práctica diaria, por ejemplo leyendo el periódico.

En la siguiente tabla se muestran algunos ejercicios de memoria, indicados especialmente en fases leves y moderadas del deterioro

TIPO DE MEMORIA	EJERCICIOS PARA SU ESTIMULACION. EJEMPLOS.
MEMORIA SENSORIAL	- Identificar el número de cubos que forman una figura geométrica. - Escuchar una canción conocida y recordar las palabras que dice en su estribillo. - Recordar y repetir una secuencia rítmica realizada con las manos, golpeando la mesa, etc.
MEMORIA A CORTO PLAZO O MEMORIA OPERATIVA	- Buscar palabras en una sopa de letras. - Deletrear palabras en orden directo e inverso. - Ejecutar operaciones aritméticas mentalmente. - Realizar los pasatiempos del periódico: las siete diferencias, crucigramas, etc. - Jugar a las cartas, hacer rompecabezas, etc.
MEMORIA A LARGO PLAZO	- Recordar mensajes, avisos o recados inventados o notas importantes para el usuario. - Clasificar u ordenar distintos objetos, como alimentos, ropa, fotografías, etc. - Completar palabras de un texto leído previamente. - Explicar de memoria una receta de cocina.

Nivel severo

La intervención cognitiva se limite al uso de ejercicios prácticos con objetos reales y

de uso básico en su vida diaria como:

- Reconocimiento visual mediante ejercicios en los cuales los objetos son reales o son fotografías con un contenido emocional elevado para el enfermo por pertenecer a su propia biografía.
- Reconocimiento de los objetos; por ejemplo, de las características físicas como el color, mediante tareas de coloreado de figuras geométricas sencillas (círculo, cuadrado, triángulo, etc.), objetos muy simples (un árbol, una casa, un vaso, etc.) y la estimulación sobre las formas simples de los objetos.
- Reconocimiento espacial básico a partir de la manipulación con objetos, realizar el ejercicio dentro-fuera.
- Manipulación de los objetos reales de uso habitual para que el enfermo mantenga el mayor tiempo posible una mínima independencia en tareas cotidianas: se practica el uso del tenedor o la cuchara, el peine, etc.
- El entrenamiento, en esta etapa, se concentra en los aspectos motores de las actividades diarias más o menos complejas, tales como el aseo personal, la preparación de la comida, el uso del teléfono, etc. Con este tipo de ejercicios se estimula la memoria procedimental

Ejemplos de ejercicios en función del grado de deterioro:

NIVEL DE DETERIORO DEL PACIENTE DEMENTE	INTERVENCIÓN COGNITIVA: EJERCICIOS.
Primer nivel: DETERIORO LEVE.	- Conocimientos generales sobre el mundo. - Escritura y la lectura. - Capacidades básicas: atención, orientación y memoria.
Segundo nivel: DETERIORO MODERADO.	- Estímulos más simples que en el nivel anterior. - Ejercicios orientados a conservar la memoria remota (M.L.P.). - Aspectos cognitivos más instrumentales: lenguaje, percepción visual y capacidades práxicas (destrezas motoras). - Lectura.
Tercer nivel: DETERIORO GRAVE.	- Estimulación de la memoria procedimental. - Ejercicios con objetos reales y de uso básico en su vida diaria. - Promoción de aspectos motores de las ABVD (aseo personal, preparación de la comida, el uso del teléfono, etc.). - Interacción con el ambiente y para la adaptación a su entorno: reconocimiento visual de objetos, reconocimiento espacial y manipulación de objetos de uso habitual.

Para ampliar información consulta
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/maroto-memoria-01.pdf

1.2.- Técnicas para el entrenamiento de la atención.

La atención es una función cognitiva importante para poder concentrarse en las actividades y así poder incorporar informaciones a través de la fase de registro de la memoria.

FACTORES CONDICIONANTES

Determinantes externos de la atención son los que proceden del medio y posibilitan que el individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, depende del medio ambiente.

Son los siguientes:

- Potencia del estímulo, por ejemplo un sonido potente llama nuestra atención.
- Cambios, las cosas que son distintas a lo habitual llaman nuestra atención, por ejemplo si aparece una pintada en un muro por donde pasamos a diario. Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la situación de estabilidad.
- Tamaño, muy usado en publicidad aunque es un estímulo menos intenso que la potencia.

- Repetición. Aunque se trata de un estímulo débil. Es muy utilizado en anuncios comerciales.
- Movimiento.
- Contraste sobre lo que le rodea

Determinantes internos de la atención o los también llamados propios son los que dependen del individuo, son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la atención, sino también su rendimiento.

Son los siguientes:

- Emoción.
- Estado orgánico se relaciona con las necesidades del individuo en ese momento, por ejemplo si una persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad.
- Intereses, por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas.
- Sugestión social.
- Curso del pensamiento, independientemente de los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y un estímulo relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su atención en forma inmediata.

La Atención voluntaria

Es la motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado, queremos atender algo por que nos interesa, no porque capte nuestra atención.

Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la "fuerza de voluntad"

CLASIFICACIÓN

La atención puede ser de tres tipos:

Atención activa y voluntaria: se orienta y proyecta mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica y en su aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. También se puede llamar atención deliberada.

Atención activa e involuntaria orientada por una percepción.

Atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo.

Atención simultanea es la que se da cuando, para realizar una tarea, el sujeto debe atender a dos estímulos al mismo tiempo, teniendo que compartir (o dividir en dos

focos la atención) su capacidad cognitiva porque la tarea a realizar es compleja. Por ejemplo cocinar mientras se habla por teléfono.

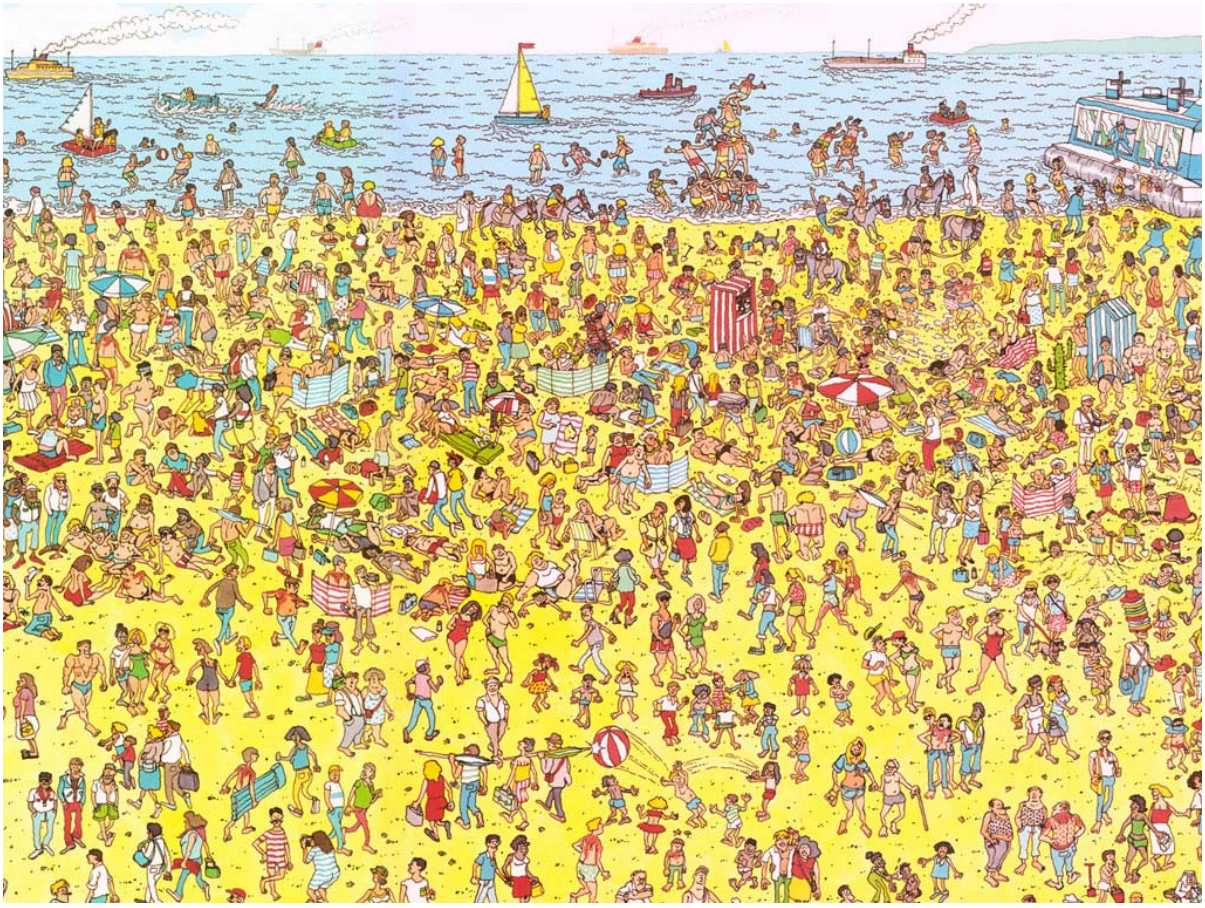
Atención sostenisda es la que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente en una tarea y puede ocuparse en su realización durante un periodo de tiempo prolongado.

En esta tabla encuentras algunos ejemplos de intervención sobre la atención

INDICACIONES VERBALES	
¿Cuántas figuras son iguales al modelo 'ç'?	ç & % = ç s ç * + ^ % = & @ ç $ ^ ç ç * # & %
Si lees una letra sí y otra no, encontrarás en este cuadro una frase. Escríbela a continuación_____ _____	M T E K G A U G S H T H A A E G L I F P U Y T S B E O D L A
Describe este objeto: su forma, su volumen, su color, dónde está ubicado, para qué sirve, e	

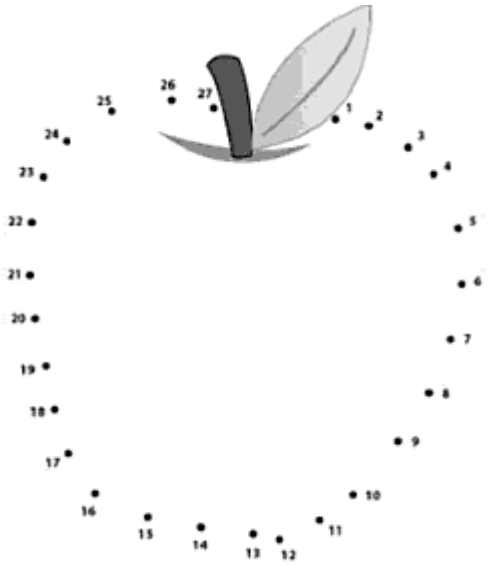
Otros ejercicios podrían ser por ejemplo:

- Encontrar un determinado objeto o imagen en una lámina de dibujos, por ejemplo buscar a Wally



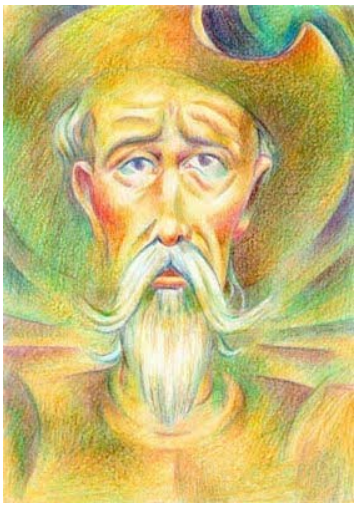
¿lo has encontrado?

- Seguir los números para obtener una figura



- Leer un texto y pedir que recuerden las cifras que en él aparecen
- Ejercicios de completar palabras
- Etc.

1.3.- Técnicas para el entrenamiento de la orientación espacial, temporal y personal.



La orientación en ESPACIO, TIEMPO y PERSONA, entendida como el conocimiento que el sujeto tiene del entorno espacial y temporal en el cual se desenvuelve, se relaciona con capacidades cognitivas como la atención y vigilancia, la memoria reciente, el conocimiento autobiográfico y la proyección en el futuro.

Los objetivos que pretende conseguir son

- Favorecer y activar la percepción de donde se está y saber orientarse en el tiempo (hora, día de la semana, día del mes y año)
- Saber reconocerse en un lugar

Se recomienda:

- Usar recursos como por ejemplo los calendarios, relojes, mapas, etc. que mejoren la orientación
- Usar ayudas de memoria como las agendas. Se puede utilizar el propio calendario como agenda

EJERCICOS PARA FOMENTAR LA ORIENTACIÓN TEMPORAL

Realizar preguntas del tipo

- ¿Qué día de la semana es hoy?
- ¿en qué fecha estamos?
- ¿En qué mes?
- ¿En qué estación del año?
- Si vamos a comer ¿qué hora puede ser?
- En una echa determinada, por ejemplo el 24 de diciembre se preguntará ¿qué se celebra? ¿qué es típico de estas fechas? ¿mañana qué se celebra?

EJERCICOS PARA FOMENTAR LA ORIENTACIÓN ESPACIAL

Realizar preguntas del tipo

- ¿dónde estás?
- ¿qué es este sitio?
- ¿en qué ciudad?

EJERCICOS PARA FOMENTAR LA ORIENTACIÓN PERSOMAL

- ¿Cómo se llama?
- ¿En qué año nació?
- ¿qué edad tiene
- ¿está caso/a?
- ¿Tiene hijo/as? ¿qué edades?
- ¿cuál es su número de teléfono?

1.4.- Técnicas para el entrenamiento del razonamiento.

El razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En sentido más restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento:

1. El razonamiento argumentativo en tanto actividad mental se corresponde con la actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento.
2. El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis.1 Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico. Por ejemplo el razonamiento deductivo (estrictamente lógico), el

razonamiento inductivo (donde interviene la probabilidad y la formulación de conjeturas) y razonamiento abductivo, entre otros.

Unos ejercicios que van a servir para ejercitar el razonamiento son por ejemplo

- Asociar a una serie de palabras un concepto. Por ejemplo:

  - verde, azul, gris, blanco y rojo son _____
  - Oscar, Andrés, Arturo y Jaime son _____
  - margarita, rosa, clavel y geranio son _____

- Completar las palabras con la letras que falta

  - Amb__lat__r__o
  - G__solin__.
  - Ab__g__d__

- Describir un lugar concreto repuesta de la pregunta formulada:

  - ¿Dónde se compra el pan?
  - ¿Dónde comes?

- Completar las frases

  - El primer día de la semana es _____
  - El mes de agosto pertenece al _____
  - El hijo de mi hija es mi _____

- Señalar en una serie unos determinados valores u objetos

  - - señala los números pares

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

- Continua restando 2 hasta llegar a 0

100	98	96							
									0

- Ordenar de mayor a menor

  33 € 68 € 36 € 28 €

- Señalar ala hora correcta en el reloj

Las cuatro y media	
Las seis menos cuarto	
Las tres y cuarto	
Las nueve y veinte	
Las dos y cinco	
La una	
Las doce menos cinco	
Las ocho menos veinticinco	

- Etc.

1.5.- Elaboración de estrategias básicas de intervención.

Antes de programar una estrategia de intervención en las funciones cognitivas, deberemos realizar una evaluación del estado en que se encuentran. Diferentes escalas nos permiten conocer el grado de deterioro del estado cognitivo de la persona, entre los más utilizados está : y La escala de Deterioro Global de Reisberg (GDS).

- el Mini mental de LOBO (versión adaptada de MMSE de Folstein) (http://www.hipocampo.org)

- Global Deterioration Scale (Escala de deterioro global) de Reisberg (http://www.hipocampo.org/reisberg.asp)

- Para conocer las posibilidades de intervención con un usuario con Déficit Intelectual consultaremos los manuales DSM-IV y CIE-10, en función de la discapacidad entrenaremos el lenguaje (pronunciación y gramática) y la atención si el deterioro es ligero; la atención, la memoria, el lenguaje, y la comprensión cuando el deterioro es grave; cuando el déficit sea profundo realizaremos ejercicios de conceptos espacio-temporales, habilidades comunicativas básicas y ejercicios adaptados de memoria

Podemos señalar unas características específicas en relación a las funciones cognitivas según la EDAD, DISCAPACIDAD o TRASTORNO, que nos servirán para orientar la intervención.

PERSONAS MAYORES
- Debido a pérdidas visuales y auditivas suelen tener afectadas la ATENCIÓN y la PERCENCIÓN. - Suelen tener OLVIDOS y el efecto " en la punta de la lengua" - Disminuye la AGILIDAD MENTAL, por lo que es más difícil realizar aprendizajes nuevos - Memoria a Corto Plazo (MCP) está afectada pero no la MLP(largo plazo) - Es importante dejar TIEMPO para realizar los ejercicios - Adaptar los ejercicios al nivel de cada persona para evitar el aburrimiento o la frustración.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Dificultad para COMPRENDER y elaborar pensamientos abstractos - Les cuesta centrar la atención - Dificultades para ordenar la información - Deberemos presentar la información de forma clara y sencilla - Deberemos realizar sesiones cortas para mantener la atención.
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
- Tendrán alterada la percepción de la realidad - Se vuelven desorganizados en el tiempo - Tienen dificultades para retener la información - Entrenaremos la ATENCIÓN ,la ORIENTACIÓN y la MEMORIA
PERSONAS CON DEMENCIAS
- Valoraremos el grado de deterioro cognitivo - Trabajaremos fundamentalmente la MEMORIA, LA ATENCIÓN, EL LENGUAJE - Entrenamiento en AVD

- Deberemos adaptar los ejercicios a sus posibilidades
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
- La falta de experiencias y de realización de movimientos puede llevar a un deterioro cognitivo - Trabajaremos la ORIENTACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL - Entrenamiento en todas las funciones cognitivas
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
- Valoraremos si la discapacidad es congénita o adquirida y resto visual o auditivo que posee la persona. - Es importante la estimulación del resto de los sentidos - Valoraremos el grado de motivación o de depresión que pueda sufrir la persona - Adecuar los materiales y ejercicios para evitar la frustración

2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas de la institución:

En las instituciones sociosanitarias es frecuente encontrarnos con personas que tienen la autonomía personal limitada o que corren grave riesgo de tenerla, por lo tanto el mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal será un aspecto muy a tener en cuenta.

El aspecto de atención a las necesidades sanitarias (necesidades básicas fisiológicas) de la vida en las personas usuarias sin autonomía se ha trabajado en diversos apartados de los MF 1 y 2. Pero también encontramos pacientes con necesidades sanitarias que, además, manifiestan dificultades de socialización o problemas emocionales severos; y también personas que necesitan de servicios terapéuticos y educativos específicos. A estos les dedicaremos los siguientes apartados, con especial interés, nos referimos a los pacientes que presentan una discapacidad de origen psíquico como las demencias, las discapacidades intelectuales (DI) y los trastornos mentales graves (TMG).

Antes de comenzar con las reflexiones, sea cual sea la técnica, procedimiento o estrategia utilizada siempre habrá que:

- Hablar con corrección y dirigirse a la personas con respeto.
- Tener en cuenta que como profesionales sociosanitario debemos ser modelo a seguir en cuanto a la manera de comportarse, comunicarse, tomar decisiones, resolver conflictos, etc.

2.1.- Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención.

Con la expresión “conducta problemática” nos referimos a aquellas conductas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente el desarrollo personal del individuo, así como a sus oportunidades de participación en la comunidad.

En la actualidad el planteamiento de modificación de conductas problemáticas, más extendido es el APOYO CONDUCTUAL POSITIVO basado en remediar condiciones ambientales y/o déficits en habilidades.

El Apoyo conductual positivo centra la atención en crear y apoyar contextos que incrementen la calidad de vida (desarrollo personal, salud, social, familiar, trabajo, ocio y tiempo libre, etc.), haciendo que las conductas problemáticas para aquellas personas que las presentan sean menos eficaces, eficientes y relevantes y que las conductas alternativas sean más funcionales.

Principios del apoyo conductual positivo

- La conducta problemática tiene una función para la persona, actúa asíi porque de alguna manera obtiene un beneficio.
- La conducta problemática está relacionada con el contexto.
- Una intervención eficaz está basada en la comprensión de la persona, su conducta y contexto social.
- El plan de apoyo debe tener en cuenta los valores de la persona, respetar a su dignidad, y aceptar sus preferencias y aspiraciones.

Características del apoyo conductual positivo

- Está basado en la evaluación funcional, vinculando variables ambientales con las hipótesis relativas a la función de la conducta problemática.
- Es global e incluye intervenciones múltiples.
- Trata de enseñar habilidades alternativas y de adaptar el ambiente.
- Refleja los valores de la persona, respeta su dignidad y sus preferencias, y trata de mejorar su estilo de vida.
- Se diseña para ser aplicado en contextos de la vida diaria, haciendo uso de los recursos disponibles y basándose en una visión compartida del problema
- Mide el éxito de los programas por el incremento en la frecuencia de la conducta alternativa, el descenso de frecuencia de la conducta problemática y por mejoras en la calidad de vida de la persona.

Fases del proceso de apoyo conductual positivo

- Identificación y clasificación de la conducta problemática.

- Principios y valores, esto es establecer las “regles del juego” que regularán el funcionamiento del equipo de apoyo

- Evaluación funcional.

  Hay que comprender conjuntamente la conducta concreta de la persona y analizar cómo estamos actuando ante ese comportamiento problemático. Los acuerdos necesarios en esta fase son dos:

- Qué estrategia inicial de intervención en crisis se va a adoptar.
- Qué sistemas de observación y registro vamos a utilizar.

- Elaboración del Plan de Apoyo Conductual.

  Se consensúa a partir de los resultados de la evaluación funcional

- Ejecución del Plan de Apoyo Conductual.
- Seguimiento del Plan de Apoyo.

2.2.- Técnicas de resolución de conflictos.

Las técnicas de resolución de conflictos son procedimientos por los cuales un conflicto se resuelve por medios no violentos y de forma relativamente estable, a través de:

- El análisis e identificación de las causas (directas o indirectas)
- el establecimiento de las condiciones en las que las necesidades e intereses de todas las partes enfrentadas puedan ser satisfechas simultáneamente.



Entre esos procedimientos, destacan como técnicas principales de resolución de conflictos la negociación, la mediación y el arbitraje.

1) NEGOCIACIÓN

Es la forma fundamental de resolución de conflictos, generalmente voluntaria, y que implica la discusión entre las partes en disputa con el objeto de alcanzar un acuerdo o arreglo en el conflicto que les enfrenta.

Hay de cinco posibles estrategias de negociación:

Flexibilidad: implica la renuncia de una de las partes a todo o casi todo de lo que pretende conseguir, puesto que considera que complacer a la otra parte o evitar la disputa es más importante que vencer.

Rivalidad: supone que las partes entran en competencia para obtener la mayor ventaja posible, empleando para ello medios como la coerción y la presión que obliguen a la otra parte a realizar concesiones.

Solución de problemas: se trata de una estrategia de colaboración en la que los oponentes trabajan juntos para alcanzar una solución que satisfaga los intereses y las necesidades de ambas partes.

Inacción: las partes en conflicto hacen el menor esfuerzo posible por negociar, de forma que, aunque en ocasiones un retraso haga aumentar las oportunidades para lograr un acuerdo posterior, esta estrategia deriva habitualmente en la ruptura de la negociación.

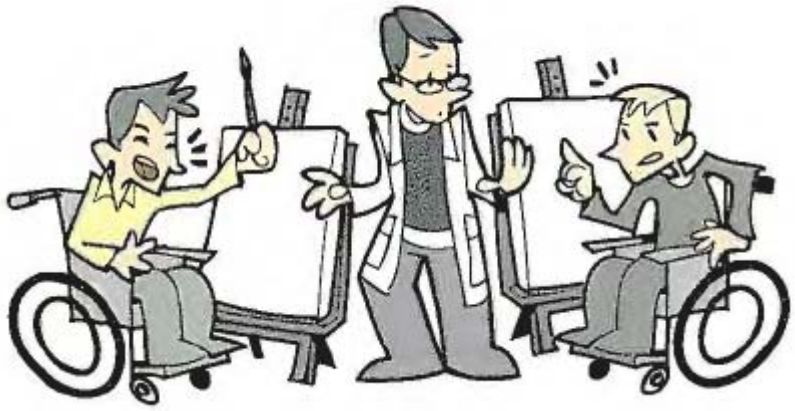
Abandono: esta postura supone el fin de la negociación y obliga a ambas partes a depender para la consecución de sus fines de medios alternativos al acuerdo negociado.

2) MEDIACIÓN

La mediación como método de resolución alternativa de disputas implica la intervención en el proceso de negociación de una tercera parte neutral e imparcial, cuyo papel consiste en asistir a las partes en su efectiva comunicación, en el análisis del conflicto y en la búsqueda de una solución aceptable para todos.

Idealmente, la persona mediadora no está vinculada a ninguna de las partes enfrentadas ni tiene interés por un resultado específico de la negociación, de forma que cuenta en su labor con la confianza y legitimación de todas las partes implicadas.

Otro rasgo definitorio de este procedimiento es que la figura del mediador no tiene capacidad de decisión, sino que se limita a guiar a las diferentes partes durante la negociación, facilitando la definición del problema y de los intereses particulares, la comprensión de los puntos de vista opuestos y la elaboración de un arreglo que cuente con la aceptación general.



3) ARBITRAJE

Proceso de resolución de conflictos en el que las partes en disputa acceden a presentar su caso ante un tercer participante neutral e independiente, quien escucha los argumentos de ambos lados y posteriormente adopta una decisión, normalmente final y vinculante.

El arbitraje difiere de la mediación, por lo tanto, en que la tercera parte que interviene en el conflicto sí tiene capacidad decisoria, si bien las partes enfrentadas mantienen el control sobre el conjunto de cuestiones a resolver y con frecuencia también sobre los aspectos de procedimiento.

2.3.- Procedimientos y estrategias de modificación de conducta.

Las técnicas de modificación de conducta son un conjunto de estrategias y procedimientos que eliminan los comportamientos inadecuados, y enseñan y refuerzan las conductas adaptadas relacionadas con la adquisición de hábitos de autonomía personal.

Las técnicas de modificación de conducta se basan en la relación que existe entre la realización de una conducta y las consecuencias que obtengamos de ella. Si las consecuencias son positivas tenderemos a repetir la conducta (comportamiento), si son desagradables o negativas, se irán eliminando.

A continuación, presentamos las técnicas de modificación de conducta de las utilizadas para promover conductas adecuadas o para disminuir conductas inadecuadas. Son las siguientes:

REFUERZO POSITIVO



El refuerzo positivo es una técnica conductual que consiste en presentar una consecuencia positiva

inmediatamente después de que el residente emita una conducta adecuada; esto hará que aumente la probabilidad de que dicha conducta se presente nuevamente en el futuro.

El refuerzo puede ser material (un objeto como recompensa; por ejemplo, un alimento o una bebida preferida por la persona) o social. Los reforzamientos sociales son consecuencias placenteras que pueden ser de tipo verbal (elogios, sonrisas, etc.) o físico (besos, abrazos, etc.).

REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES

Esta técnica tiene como fin eliminar una conducta problemática. Se basa en la administración de recompensas de forma continua a aquellas conductas que son incompatibles con la que se quiere suprimir, mientras se ignora la conducta que se desea eliminar.

La conducta alternativa resulta incompatible con la conducta indeseable y, por eso, se premia.

REFORZAMIETNO DE TASAS BAJAS DE CONDUCTA

Se trata de un abordaje específico para disminuir pero no suprimir una conducta determinada. Por ejemplo, en los casos en que un usuario reclama constantemente la atención, el profesional sólo se la prestará después de haber realizado la tarea, evitando así las interrupciones frecuentes. Si se levanta o intenta boicotear continuamente la dinámica del grupo, sólo se le da el turno después de habérselo concedido a otros compañeros para impedir que acapare toda la discusión.

EXTINCIÓN

Un procedimiento que es aplicado ante conductas que no se adaptan a la vida residencial normalizada (por ejemplo, escupir en el suelo, orinar en una papelera, etc.)

Consiste en retirar la atención; es decir, suprimir la mirada, el contacto corporal o verbal, mientras el usuario está realizando un comportamiento problemático.

Con frecuencia, al principio de usar esta técnica, se produce un aumento momentáneo de la conducta que precisamente se quiere eliminar (explosión de respuestas). Una vez pasado este aumento inicial, observamos que se produce una disminución gradual de la conducta problema.

ECONOMIA DE FICHAS

Es una variante especial que conjuga la aplicación del refuerzo y la extinción.

En lugar de utilizar los premios o reforzadores directamente, se emplean fichas que, en otro momento, el usuario podrá intercambiar por una variedad de actividades agradables y bienes de consumo. Los privilegios utilizados como premio sólo podrán obtenerse a través de fichas; así, cuando aparecen conductas indeseables y se les retiran fichas, lo que en realidad se le está retirando son las consecuencias placenteras que hubiese tenido el buen comportamiento.

Esta técnica resulta muy útil con las conductas alborotadoras; por ejemplo, se le entregan al usuario 10 fichas al comenzar la actividad por la mañana y, cada vez que realiza una conducta problemática, se le quita una. Las fichas que conserve pueden ser canjeadas por reforzadores; por ejemplo, poder realizar actividades que le resulten atractivas.

MODELADO

El modelado consiste en dar al individuo la oportunidad de observar, en una persona significativa para él, la conducta nueva que se desea implantar o modificar. A continuación, el paciente debe copiar esa conducta de forma inmediata o tras un intervalo de tiempo muy breve.

TÉCNICAS BASADAS EN EL PRINCIPIO DE CASTIGO

Son las siguientes:

- Coste de respuesta, también llamado castigo negativo: consiste en quitar, suprimir algo que gusta (algún reforzador positivo disponible) como consecuencia de una conducta desajustada. De este modo, se produce la pérdida de reforzadores tras una conducta negativa. Por ejemplo, inmediatamente después de que el usuario manifieste una intensa rabieta, se produce la pérdida de puntos, fichas o alimentos no esenciales como refrescos, café, golosinas, etc.; o se elimina la posibilidad de que el usuario realice una actividad agradable que antes sí estaba en su plan individual.
- Tiempo fuera: es la privación temporal de un reforzador social, como es la participación y la integración del usuario en una actividad, como consecuencia a una conducta problemática. La estrategia más frecuente es que el residente salga de la sala durante un tiempo determinado que, en todos los casos, será breve.

SOBRECORRECCIÓN

La técnica consiste en restituir o reparar los daños ocasionados por el usuario y, además, la práctica positiva de la conducta apropiada. Por ejemplo, un residente en un arranque de cólera vuelca la mesa donde están trabajando; el profesional le exige que la coloque en la posición correcta (restituir). Además, al acabar la actividad, tiene que ordenar el mobiliario de la misma sala (práctica positiva).

REPRIMENDAS

Son las riñas verbales cuando aparecen conductas problemáticas leves. Han de aplicarse inmediatamente después de la conducta inapropiada y deben ir precedidas de una señal (un tono verbal, un gesto determinado, etc.) del profesional.

SACIACIÓN

La saciación consiste en la administración de un reforzamiento positivo, en grandes cantidades, durante un intervalo temporal breve.

2.4.- Comportamientos en grupo.

Los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas están influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas o implícitas sugiere que, de manera indefectible, estamos influenciados socialmente, incluso cuando no hay otros individuos presentes (la televisión por ejemplo) o seguimos normas culturales internalizadas.



Una persona puede comportarse de manera muy diferente en grupo, cuando están en alguna actividad ocupacional colectiva, como jugando al bingo por ejemplo, que cuando está sola.

En relación con el grupo, el profesional debe crear un ambiente adecuado. En este punto son muy importantes:

- Las condiciones materiales de la sala: disposición de los muebles, situación de los participantes unos respecto a otros, silencio ambiental, ambiente agradable, etc.
- Desarrollar y reforzar en el grupo las actitudes de cooperación y participación.

- Un grupo funciona mejor cuando el puesto de líder va rotando de manera informal entre todos los miembros, según las necesidades, aptitudes, tareas y circunstancias del grupo.
- Un líder grupal positivo es aquel que facilita las tareas y gestiona de forma saludable la dinámica emocional del grupo. Por el contrario, un líder grupal negativo distorsiona, interrumpe y dificulta las actividades que propone el cuidador y, por tanto, pone obstáculos a su desempeño profesional.
- El clima grupal debe favorecer la satisfacción de necesidades individuales como:
    - Expresar los propios pensamientos y sentimientos.
    - El deseo de ser aceptado y comprendido.
    - La necesidad de ser considerado como valioso.
    - El deseo de triunfar y tener éxito.
    - La necesidad de afecto.
    - Fomentar la comunicación y las interacciones entre los miembros.
    - Reducir las tensiones que se produzcan en el grupo.

2.5.- Utilización de las dinámicas de grupo.



Las Dinámicas de grupo son técnicas en las que la las personas interaccionan entre si.

Antes de antes de poner una de ellas en práctica, deben ser analizados previamente una serie de factores:

- Número de personas (tamaño del grupo).
- Edad (edad media de los participantes, pudiendo distribuirlos en subgrupos).
- Capacidad física y psíquica de los miembros del grupo (las personas dependientes).
- Características específicas y necesidades concretas de los usuarios.
- Los objetivos a conseguir con la actividad.
- La madurez y el entrenamiento del grupo en este tipo de actividades.
- La experiencia y capacidad del profesional para llevar a cabo la técnica
- Los recursos materiales disponibles

TIPOS DE DINÁMICAS

DINÁMICAS de PRESENTACIÓN

Buscan el conocimiento inicial en el primer contacto grupal, el conocimiento permite una mejor integración grupal.

Se utilizan técnicas como:

- "la tarjeta de presentación", en la que cada uno se dibuja, escribe su nombre y define sus gustos y aficiones, posteriormente por parejas se van presentando y realizando preguntas que surjan de esta presentación a través del dibujo.
- Entrevistas por parejas
- Juegos de presentación, etc.

DINÁMICAS de CONOCIMIENTO

Su objetivo es el conocimiento más profundo de los miembros del grupo tras la etapa de presentación.

Se utilizan técnicas como:

- el sociograma en el que cada participante define con que personas realizaría las acciones definidas por el animador, como puede ser irse al cine, hacer un trabajo, contar un secreto, etc. Después cada uno contesta las preguntas y se realiza un mapa de las relaciones del grupo que necesariamente da pie a hablar de las necesidades de cada uno en el grupo, provocando cierta movilización en las relaciones.

DINÁMICAS de COMUNICACIÓN

Con estas técnicas dse pretende aprender a entenderse individual y colectivamente. Son ejercicios en los que se ejercitan aspectos concretos de la comunicación, especialmente útiles en la formación del grupo y en las crisis y conflictos pues preparan a los miembros del grupo para afrontarlos.

Se utilizan técnicas como:

- "venderse", en la que cada participante tiene que venderse con sus capacidades, lo que favorece la capacidad de expresión y autovaloración.
- trabajo en tríos,
- elaboración de pequeños trabajos adecuados a las capacidades físicas y psicológicas de las personas usuarias, pueden ser pequeñas cosas como que expliquen cuál era su oficio, una receta-... Luego hay que exponerlas

DINÁMICAS de COOPERACION

Con ellas se quiere lograr el desarrollo de experiencias de colaboración en el grupo., que el grupo aprenda a construir colectivamente con actitudes positivas. Son útiles en la formación del grupo y al comienzo de cada ciclo de trabajo para poner a punto la capacidad constructiva grupal y observar las dificultades en el afrontamiento de la tarea. Son pruebas en las que es necesaria la colaboración de todos los miembros del grupo para conseguir los objetivos grupales.

Se utilizan técnicas como:

- “el nudo”, en la que con los ojos cerrados se agarran las manos, colocadas en alto, de los miembros del grupo, formándose un nudo humano que al abrir los ojos hay que deshacer con la colaboración de todos.
- el espacio más pequeño, construcción de maquinas, juegos colectivos de lógica, etc.

DINÁMICAS de DISCUSION Y ANALISIS

Facilitan el debate y la profundización en los temas de trabajo del grupo. Son útiles en las fases previas a la acción, para aumentar el conocimiento y orientar y dar sentido a las iniciativas del grupo.



Se utilizan técnicas como: el estudio de casos, el role playing, la mesa redonda,…

DINÁMICAS de EXPOSITIVAS

Tienen como objetivo expresar el conocimiento previo que se tiene de un tema de la forma más completa posible y orientado a que el grupo lo conozca. Se logra ampliar los conocimientos a través de aportaciones externas al grupo.

Se utilizan técnicas como:

- "el mural", en la que por subgrupos se exponen los conocimientos y las opiniones que se tiene sobre un tema concreto plasmándolo en forma de mural con escritos, fotos, dibujos, etc.
- el simposio, el periódico, un programa de radio, teatro
- etc.

DINÁMICAS de TOMA DE DECISIONES

Facilitan la capacidad grupal de decidir. En ocasiones se utiliza sin que existan problemas concretos, convirtiéndose en un entrenamiento en frío y en otras ocasiones facilitan la toma de decisiones que el grupo debe hacer.

Se utilizan en la formación del grupo y en la preparación y desarrollo de la tarea.

Se utilizan técnicas como:

- "la pecera", en la que un grupo grande se divide en grupos pequeños que debaten un tema y luego, a través de representantes y de manera pública, se debate y decide lo que se necesita.
- la lluvia de ideas o brainstorming, que facilita la búsqueda de posibilidades para ajustar la decisión y el consenso.

DINÁMICAS de RESOLUCION DE CONFLICTOS Y PROBLEMNAS

Su finalidad: es la de aprender a afrontar los conflictos grupales tanto los que existen en el presente como los que se puedan presentar. Supone ejercitar habilidades necesarias para el afrontamiento y acostumbrar al grupo a el ejercicio de enfrentarse con los problemas

Se utilizan técnicas como:

- "el intercambio de roles", en la que los participantes en un conflicto, o personas sustitutas elegidas para ello, intercambian las posiciones con las que se identifican en un conflicto, de manera que los participantes puedan comprender en cierta medida la experiencia de la persona que está al otro lado.
- la retroalimentación,
- el juego de roles, etc.

DINÁMICAS de EVALUACION

Se logra valorar el desarrollo de una iniciativa grupal, cumpliendo tanto una función de expresión interna como de retroalimentación grupal.

Se utilizan después de realizar una tarea o parte de una tarea.

Se utilizan técnicas como:

- "el termómetro", en la que cada uno asocia los aspectos que se quieren evaluar a una determinada temperatura que significa que cuanto más alta mayor valoración tiene. Esto permite a un grupo expresar su opinión y sacar conclusiones sobre como ha ido la actividad realizada.
- las fichas,
- las asambleas de evaluación, etc.

Cuando pongamos en marcha una dinámica grupal es importante tener en cuenta:

- Establecer objetivos concretos.
- Graduar la dificultad de las dinámicas.
- Valorar las diferencias individuales.
- Procurar que las dinámicas lleven al éxito.
- Evitar la eliminación de participantes.
- Utilizar técnicas variadas poco complejas.
- Dar instrucciones claras.
- No potenciar la competitividad.

Además, no hay que olvidar que la mayoría de las personas en situación de dependencia son muy sensibles al medio, por lo que tendremos que cuidar mucho los siguientes factores:

- La atmósfera humana; es decir, que los participantes se conozcan los unos a los otros; que exista un nivel suficiente de confianza o, al menos, de cooperación, comunicación interpersonal, etc.
- El entorno material, debido a que el ambiente físico determina el éxito de las dinámicas. Nos referimos, concretamente, al contexto en el que se realizan los talleres y los objetos que rodean a los participantes. Aspectos como la iluminación, la ventilación, el ruido ambiental, las condiciones físicas del local, el mobiliario, la forma de colocar las sillas, y otros factores influyen en el grupo, creando un ánimo grupal favorable o no.

2.6.- Observación de la persona usuaria en situaciones especiales, fiestas y eventos:

Los usuarios de las instituciones están acostumbrados a vivir en un ambiente estructurado, con unos horarios establecidos, rutinas y actividades que se suceden día tras día. Estas circunstancias son útiles para poner en práctica hábitos de autonomía personal y habilidades sociales útiles en este contexto.

Pero cuando se realizan actividades que rompen esa rutina es fácil que los usuarios se desorienten.



Por ello no vamos a dejar de realizar estas actividades especiales, puesto que aportan grandes beneficios a las personas:

- Posibilidad de aplicar los hábitos de autonomía personal en la preparación de un acontecimiento extraordinario; no es lo mismo hacer un taller manual semanal, que realizar cadenetas, farolillos…para decorar las salas para un evento.
- Aumento de la autoestima y sentimiento de utilidad, por ejemplo utilizar los cubiertos delante de sus familiares.
- Mantener la orientación espacial y temporal. celebrar la Navidad, cumpleaños etc... proporcionan puntos de referencia para el usuario.
- Incremento de los vínculos con el entorno exterior al centro, salidas, excursiones hacen que el usuario se sienta conectado con el exterior

Estas actividades extras (fiestas, eventos, salidas…) deben de organizarse y desarrollarse de forma adecuada. Para planificar el evento contaremos con tiempo suficiente, deberemos concretar: los objetivos de la actividad, el número de participantes, las características del grupo, los recursos materiales y humanos y como vamos a realizar la evaluación al finalizar la actividad.

Cada profesional tendrá una tarea asignada, aún así deberá ser flexible y adaptarse a los requisitos que exija la actividad. Los profesionales deberán mantener una actitud de tranquilidad y calma; ya que si los usuarios perciben nerviosismo pueden mostrarse intranquilos. Es importante, para evitar esa ansiedad, dar información sobre las celebraciones para que así pueda ir preparándose para el momento

Técnicas básicas de observación.



Las técnicas de observación parten de la premisa de que no se puede observar todo, ni observar siempre. Suponen una decisión previa acerca de qué vamos a observar, en quién, cuándo y de qué modo (incluyendo cómo vamos a registrar y conservar la información). La observación requiere la cuidadosa elección de una persona, unos contenidos, un lugar y un tiempo para realizar esta tarea.

Podemos recoger toda esta información de diferentes formas:

a.) De forma NO ESTRUCTURADA: es decir recoger las observaciones sin haber determinado previamente lo que se va a observar. Se anotan aquellas cosas que nos han llamado la atención.
b.) De forma ESTRUCTURADA con anterioridad se definen los aspectos que se van a observar

La OBSERVACIÓN DIRECTA consiste en analizar y registrar la conducta de la persona en su ambiente natural a lo largo de un periodo amplio de tiempo.

Por otro lado, podemos utilizar la técnica de OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, la cual consiste, igualmente, en recoger información general acerca de los usuarios, pero añade la característica de que el profesional forma parte del contexto en el que se dan las interacciones personales. El cuidador persigue observar y participar (de forma simultánea) en la misma actividad que están desarrollando los usuarios. Para que los datos recogidos en la observación realizada sean fiables, es fundamental que el profesional la lleve a cabo sin interferir en las actividades de la persona dependiente ni del grupo.

Normalmente, basta con que se recoja la misma conducta problemática un número determinado de veces para que el equipo profesional identifique un patrón de comportamiento desajustado. Para identificarlo, los cuidadores deben usar un sistema de registro donde queden reflejados estos episodios de crisis. Se trata de que el cuidador describa la actividad que estaba realizando el usuario antes de manifestar la conducta en cuestión, las características de ésta, el tipo de interacciones que se daban en el contexto de su aparición, etc.

La observación puede ser individual o grupal. En la INDIVIDUAL se recogen informaciones sobre la actitud durante la fiesta (participativo, apático, indiferente…), la actitud hacia los compañeros y la relación con los profesionales. En la observación GRUPAL dirigiremos nuestra atención al clima del grupo y a las relaciones que en él se establecen.

Intervención en situaciones de crisis.

La intervención en una situación de crisis hace referencia al control que los profesionales deben aplicar en una situación crítica. Es decir, se trata de ejecutar un protocolo de intervención cuando la persona dependiente muestra o podría mostrar una conducta gravemente problemática.

El equipo de apoyo debe saber cómo desactivar una situación conductual que altera gravemente la convivencia. Para ello, resulta imprescindible que se haya concretado un protocolo de intervención, específico para la unidad residencial. Por otro lado, los cuidadores deben tener conocimiento y formación en la ejecución de las distintas estrategias que pueden ser adoptadas.

Para llevar a cabo adecuadamente este tipo de intervención, deberemos ejecutar la siguiente secuencia de actuaciones.

I. El primer paso consiste en la identificación de las situaciones que requieren ser tratadas como crisis. Igualmente, deben ser concretadas aquellas conductas que comprometen seriamente a la persona o a otros usuarios, además de definir qué consecuencias negativas siguen al comportamiento desajustado.
II. El segundo paso será valorar el nivel de riesgo físico y decidir qué procedimiento resulta más adecuado para una situación concreta de crisis.
III. Finalmente, se procede a la puesta en práctica del protocolo de emergencia y se valoran los resultados. La evaluación continua resulta indispensable para establecer si una pauta de control es pertinente y efectiva y si posee validez; es decir, si es aplicable en otra situación futura cuando las circunstancias lo demanden.

Las INTERVENCIONES EN CRISIS son:

- Restricciones físicas
- El aislamiento involuntario
- La aplicación de un medicamento (empleado para restringir las capacidades del paciente: movilidad, comunicación, reacción, etc.),



Cada vez que un usuario tenga que ser sometido a una medida de estas se pondrán en conocimiento de la familia (o en su caso, del tutor o representante legal).

En todas las ocasiones, y mientras se mantengan estas medidas, los usuarios permanecerán bajo el cuidado de profesionales cualificados y en condiciones de seguridad y de máximo respeto a su dignidad

Comunicación de incidencias al equipo interdisciplinar.

Cuando sucede un episodio de conducta problemática, el personal de atención directa, que estaba en ese instante y que intervino en situación de crisis, debe dejar por escrito constancia de lo ocurrido y notificarlo al resto de compañeros de la unidad residencial. En estas situaciones, resulta indispensable informar al equipo multiprofesional de la conducta observada, así como de la estrategia de control que ha sido aplicada.



Como mecanismo de coordinación interna, se utilizan las siguientes formas de registro:

El teléfono supone transmitir la información por vía oral, lo cual presenta varios inconvenientes: tenemos que contactar con cada miembro del equipo y repetir a cada uno la información; requiere mucho tiempo, otro inconveniente es que a veces no conseguimos contactar con los profesionales (fuera del horario laboral).

Libro-Diario de incidencias en el que los cuidadores, antes de finalizar su turno, deben dejar constancia por escrito de aquellos sucesos significativos que han ocurrido durante su jornada laboral. En el libro-diario se recogen las incidencias, las estrategias que se han utilizado en caso de un episodio de crisis, la situación en la que se quedan los residentes en ese momento y otros aspectos similares que puedan resultar relevantes para el nuevo turno de profesionales que se incorpora.

De esta manera, el personal que da el relevo posee la información necesaria para continuar con la intervención que se ha iniciado en el turno anterior.

Entre los cambios de turno debe existir un tiempo, de al menos quince minutos, para que los profesionales que dejan el servicio puedan comentar a los cuidadores que se incorporan las impresiones, las incidencias, las novedades, etc.

Las reuniones de coordinación tratan todos los aspectos que afectan a la dinámica del centro deben ser que deber ser coordinados y evaluados de forma continua.

Con el fin de que exista una buena organización entre los distintos profesionales que atienden a los usuarios, se realizan reuniones periódicas; la convocatoria a las mismas y los temas a discutir, generalmente, son propuestos desde la Dirección del centro.

Cuando la gravedad de las circunstancias lo requiera o la frecuencia con la que se lleva a cabo determinada intervención sea muy alta, se podrá convocar una reunión específica para el abordaje del tema.

En este encuentro, los miembros del equipo de apoyo exponen lo que se ha realizado ante el episodio de conducta problemática tratado, señalan las dificultades y los éxitos que han conseguido con esta actuación y comparten la experiencia con el resto de compañeros.

En grupo, se discute la pertinencia de la estrategia de intervención utilizada y se valora si ha sido útil para impedir el agravamiento de la conducta o para impedir las consecuencias negativas de un episodio de tales características. Asimismo, el equipo interdisciplinar realiza un análisis funcional de la conducta problemática.

Una vez estudiado el caso, el equipo decide el programa de modificación de conducta más indicado y propone la aplicación de la intervención elegida para esta persona cuando aparezca nuevamente la crisis. En todos los casos, los resultados de la aplicación de esta nueva estrategia serán evaluados por el equipo para confirmar su idoneidad o diseñar un nuevo programa en caso de que se haya mostrado ineficaz o inadecuado.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

1.- responde a las siguientes preguntas tipo test

1. La capacidad que permite aprender, guardar y recuperar la información para utilizarla posteriormente se denomina:

   a) Memoria.
   b) Atención.
   c) Razonamiento.
   d) Orientación.

2. La memoria sensorial es aquella que:

   a) Se refiere a la memoria del presente.
   b) Se refiere a recuerdo de informaciones que acaban de percibir.
   c) Se refiere a la memoria que almacena experiencias personales.
   d) Se refiere a la información relacionada con las habilidades.

3. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de memoria?

   a) La visualización.
   b) La técnica de los lugares.
   c) La técnica verbal.
   d) Todas son correctas.

4. La atención está condicionada por:

   a) El estímulo.
   b) La disposición del usuario.
   c) A y b son correctas.
   d) Ninguna es correcta.

5. La atención sirve para:

   a) Poder reaccionar ante los estímulos.
   b) Discriminar estímulos que deseen impedir que lleguen a la memoria.
   c) Concentrarse.
   d) Todas son correctas.

6. ¿Cuál de los siguientes es un ejercicio para mejorar la atención?

   a) Sopa de letras.
   b) Crucigramas.
   c) A y b son correctas.
   d) Ninguna es correcta.

7. Entre las recomendaciones principales para favorecer la orientación se encuentra:

   a) Adecuar el nivel de exigencia de los ejercicios a las capacidades conservadas del usuario.
   b) Utilizar recursos facilitadores como calendarios, relojes o agendas.
   c) Personalizar y reforzar siempre la ejecución de las actividades.
   d) Todas son correctas.

8. ¿Cuál de los siguientes conceptos se vincula al pensamiento?

   a) La creatividad.
   b) El razonamiento.
   c) A y b son correctas.
   d) Ninguna es correcta.

9. El proceso mental por el que se extraen conclusiones a partir de premisas más o menos explícitas se denomina:

   a) Razonamiento.
   b) Creatividad.
   c) Atención.
   d) Memoria.

10. Entre las estrategias básicas de intervención se encuentra:

    a) Realizar un diseño adecuado del programa de rehabilitación.
    b) Conocer la patología del usuario.
    c) Individualizar el entrenamiento.
    d) Todas son correctas.

11. Teniendo en cuenta el concepto del Apoyo Conductual Positivo,
    a) Las pautas serán aplicadas por los familiares, en los momentos de visitas o en salidas de la unidad.
    b) El plan de apoyo conductual debe ser llevado a cabo por todas las personas que tengan contacto directo con el usuario dentro de la residencia.
    c) El profesional observa al grupo y participa en la misma actividad que están desarrollando los usuarios.
    d) Todas son incorrectas.

2.- ¿Cómo plantearías la resolución de esta caso de conflicto?

Rodrigo es un profesional de atención sociosanitaria que trabaja en un centro de recuperación de personas con discapacidades de carácter físico y sensorial.

Ramón es uno de los usuarios con patología motórica grave con los que trabaja. El joven de 26 años es una persona con un carácter bastante fuerte que suele perder los papeles cuando alguien le contradice o no está de acuerdo con él.

El lunes pasado, en el taller de pintura, tuvo una discusión con sus compañeros y con los profesionales que lo dirigen. Durante la disputa, Ramón se enfadó mucho llegando a descalificar a algunos de ellos y abandonó el taller afirmando que no quería volver a verlos.

La realidad es que Ramón es un aficionado a la pintura y se encontraba muy a gusto con sus compañeros, pero ahora no sabe cómo resolver la situación.

3.- Enumera algunas de las estrategias de modificación de conducta, estudiadas en esta unidad, que puedan ser útiles en la intervención con personas dependientes en instituciones sociales.

4.- Completa las siguientes afirmaciones, relacionadas con el entrenamiento de las funciones mentales, con aquella función cognitiva que corresponda en cada caso:

. Los ejercicios de series numéricas concretas, nombres de los meses del año en sentido directo e inverso, el concepto numérico y el cálculo mental, y la resolución de problemas aritméticos son aplicados para el entrenamiento de _____

Practicar actividades que ejerciten la capacidad de analizar y discriminar la información y ejercicios con material visual (láminas) o material auditivo (discriminar sonidos) favorecen la rapidez o agilidad de _____

Repetir mentalmente una información, la copia de un dibujo, agrupar palabras, clasificar conceptos según categorías, etc., son actividades indicadas para el desarrollo de _____

El entrenamiento en el uso de un reloj, un diario y un libro de memoria que contiene dibujos de los compañeros, familiares, cuidadores, descripciones de la rutina diaria y sus actividades, se indica en el mantenimiento de _____

5.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas?

1. La estimulación de las capacidades cognitivas ayuda a ralentizar la pérdida de las funciones psíquicas y otras habilidades relacionadas.

2. El equipo de enfermería desarrolla un programa individual de entrenamiento cognitivo dirigido a obtener mayores niveles de independencia personal.

3. Dentro de las terapias farmacológicas aplicadas en pacientes con demencia, se encuentran los programas de psicoestimulación cognitiva.

4. La información presentada por ruta visual y de manera secuenciada es más difícil de comprender que aquélla presentada de manera auditiva.

5. La observación indirecta consiste en analizar y registrar la conducta de la persona en su ambiente natural a lo largo de un periodo amplio de tiempo.

6. La terapia de modificación de la conducta afirma que pueden producirse cambios en el comportamiento desajustado de un paciente a través de la aplicación práctica de técnicas específicas como el reforzamiento.

7. En la observación participante, el profesional forma parte del contexto en el que se dan las interacciones personales.

8. Basta con recoger un par de episodios de la misma conducta problemática para que el equipo profesional identifique un patrón de comportamiento desajustado.

9. La observación directa consiste en analizar y registrar la conducta de la persona en su ambiente natural a lo largo de un periodo amplio de tiempo.

10. Se aconseja mostrarse como una persona con autoridad y distante.

11. Debemos estar atentos y observar las necesidades, inquietudes y problemas de cada usuario.

12. Intentar no situarse en el lugar del otro para entenderle mejor, porque se pierde objetividad y no somos un apoyo

13. Se pueden observar aspectos grupales e individuales

14. Es importante que el observador tenga buena memoria, ya que no se debe dejar constancia escrita de lo analizado

15.)Antes de observar tendremos que establecer los criterios de observación

6.- Nombra los factores que deben ser analizados por el profesional antes de la aplicación de una dinámica de grupo